李志道悬钟穴研究撷粹

田　苑[1]　李　婷[1]　时旭平[1]　李　岩[2]　李兰媛[3]
（1.天津中医药大学，天津 300193；2.天津市公安医院，天津 300042；
3.天津中医药大学第一附属医院，天津 300193）

摘　要　通过对李志道教授论文的研读，总结出其就悬钟穴的3点研究考证：悬钟穴的定位在腓骨前缘，而非腓骨后缘；悬钟穴为“诸阳会”，是阳维脉的起点，而非李时珍所言金门穴；悬钟穴并非绝骨，也非髓会，髓会绝骨之绝骨当为阳辅穴。

关键词　悬钟穴　阳维脉　阳辅　绝骨
中图分类号　R224.2　　**文献标识码**　A　　**文章编号**　1672-397X(2015)05-0068-02

李志道教授考《内经》、《难经》、《针灸甲乙经》，对于悬钟穴有3点新的认识。笔者查阅李志道教授的多篇文献，发现其对一个腧穴的研究能提出如此诸多的见解，乃至对前人之论有所颠覆，实属少见。今撷粹于下，与同道共享。

1　悬钟穴定位应在腓骨前缘

有关悬钟穴的定位是在腓骨前缘还是在腓骨后缘，历来争议很大，临床使用时也不尽统一。邱茂良主编的《针灸学》（1985年10月第1版，2014年1月第44次印刷）是在腓骨后缘：“外踝高点上三寸，腓骨后缘”；石学敏主编的《针灸学》（2007年6月第2版，2009年8月第22次印刷）是在腓骨前缘：“外踝高点上3寸，腓骨前缘”。而造成几版教材关于悬钟穴定位分歧的主要原因是，在《针灸甲乙经》中只提到悬钟穴在“足外踝上三寸动脉中，足三阳络，按之阳明脉绝乃取之”，即只言明在外踝上三寸，并未言明是在腓骨前缘还是腓骨后缘。李志道教授考《针灸甲乙经》和《内经》原文认为，悬钟穴确在腓骨前缘。《针灸甲乙经》是我国现存最早的针灸学专著，也是最早、最多收集和整理古代针灸资料的重要文献。悬钟穴的定位最早记载于《针灸甲乙经》：“悬钟，在足外踝上三寸动脉中，足三阳络，按之阳明脉绝乃取之。”即悬钟穴位于足外踝上三寸处，此处有动脉搏动，如果按压悬钟穴，则可使足背动脉

[3] Falsetti P,Acciai C,Palilla R,et al. Oropharyngeal dysphagia after stroke: Incidence,diagnosis,and clinical predictors in patients admitted to a neurorehabilitation unit. J Stroke Cerebrovasc Dis,2009,18(5):329
[4] 莫锐钊，蒋超.脑卒中吞咽困难患者的康复护理进展.护理学杂志，2009，24(15)：90
[5] 中华神经科学会，中华神经外科学会.各类脑血管疾病诊断要点.中华神经科杂志，1996，29(6)：379
[6] 大西幸子，孙启良.脑卒中患者摄食-吞咽障碍的评价与训练.中国康复医学杂志，1997，12(3)：141
[7] 徐月花.康复训练综合疗法治疗脑梗死后吞咽困难.现代中西医结合杂志，2008，17(8)：1252
[8] 石学敏.针灸学.北京：中国中医药出版社，2008：105
[9] 朱镰连.神经康复学.北京：人民军医出版社，2001：551
[10] Alonso de Lecinana-Cases M,Perez-R GE,Diez-Tejedor E. Recommendations for stroke treatment and prevention. Rev Neurol,2004,39(5):465
[11] 闫仲超，许蕾，许晓花，等.综合疗法治疗脑卒中100例疗效观察及综合生活质量评价. 中国医学创新，2012，9(4)：7
[12] 廖喜琳.脑卒中病人吞咽障碍的早期康复训练.全科护理，2009，7(3C)：834
[13] 王莹，裴景春.针灸治疗中风后吞咽障碍研究进展.实用中医内科杂志，2011，25(12)：3
[14] 廖色青，夏令琼，梁云花.廉泉风池金津玉液穴位按揉对脑卒中患者吞咽功能的影响.护理学报，2013，20(2A)：66

第一作者：濮红萍（1976—），女，本科学历，主管护师，护理学专业。
通讯作者：史婷奇，副主任护师。blueshooter@sina.com

收稿日期：2015-02-06
编辑：华　由　王沁凯

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

无法触及。由此可知，悬钟穴应位于胫前动脉的走行处，而胫前动脉在小腿部的循行正是贴在胫骨外侧面走行，可知悬钟穴位于胫腓骨之间，即腓骨前缘。《内经》中记载胆经循行“下外辅骨之前，直下抵绝骨之端”，再结合《针灸甲乙经》中有关阳辅穴的定位：“阳辅者，火也，在足外踝上四寸，辅骨前，绝骨端，如前三分所，去丘墟七寸，足少阳脉之所行也，为经”，阳辅穴位于辅骨前，而胆经“下外辅骨之前，直下抵绝骨之端”，说明阳辅与悬钟应在同一条直线上，那么悬钟穴也应在“辅骨前”。这样就进一步佐证了悬钟穴定位确在腓骨前缘，而非腓骨后缘。

2 悬钟穴当为“诸阳会”，为阳维脉起点

《难经》有载：“阳维起于诸阳会也，阴维起于诸阴交也。”李时珍《奇经八脉考》载：“阳维起于诸阳之会。其脉发于足太阳金门穴，在足外踝下一寸五分，上外踝七寸会足少阳于阳交，为阳维之郄。循膝外廉上髀厌抵少腹侧，会足少阳于居髎。循胁肋斜肋斜上肘上，会手阳明、手足太阳于臂臑。过肩前与手少阳会于蠕会天髎。却会手足少阳、足阳明于肩井。入肩后会手足少阳、阳跷于臑俞。上循耳后会手足少阳于风池。上脑空、承灵、正营、目窗、临泣，下额与手足少阳、阳明五脉会于阳白。循头入耳上至本神而终。”滑寿言：“阳维所发，以阳交为郄，与手足太阳及跷脉会于臑俞，与手足少阳会于天髎及肩井，与足少阳会于阳白，上本神、临泣、正营、脑空，下至风池，与督脉会于风府、哑门，此阳维之起于诸阳之会也。”李志道教授认为，李时珍所言“阳维起于诸阳会也”只是随文引出，且并未说明金门穴即是“诸阳会”，更未明言“诸阳会”是否为另一腧穴、究竟为哪一腧穴。而滑寿在将“阳维起于诸阳会也”解释为阳维脉有能维系一身之阳的功能。而从《难经》全句看来，既有“起于”二字，则可见“诸阳会”是描述阳维脉循行的，而非描述其作用。所以李时珍之言更具合理性。以往各书都据《针灸甲乙经》载金门穴位为阳维脉起点，李志道教授认为这是对《针灸甲乙经》的曲解。查《针灸甲乙经》中阴阳跷脉、阴阳维脉、冲脉、带脉的交会穴，除郄穴外，都以“某经某经之会”的句式出现，如臑俞为“手太阳阳维跷脉之会”、承灵为“足少阳阳维之会”等[1]。但金门穴的记载则是“阳维所别属也”，即金门穴为阳维脉分支所连属处。因此金门穴只与阳维脉的一个分支相连，并非是阳维脉的起始穴。那么这里的“诸阳会”究竟是指那个穴位呢？李志道教授认为当为胆经的悬钟穴。《针灸甲乙经》载悬钟为“足三阳络”，“络”，即联络，“足三阳络”即联络足三阳经，可以说悬钟是足三阳经的交会穴，恰与“诸阳会”之意相吻合，故此悬钟穴当为阳维脉之起始处。李志道教授用同样的方法考证了“阴维起于诸阴交也”，认为“诸阴交”当为三阴交，因为《针灸甲乙经》有三阴交为“足太阴厥阴少阴之会”之记载，为三阴交为“诸阴交”、为阴维脉起始处的推断提供了进一步的佐证。阳维脉起于外踝上三寸的悬钟穴，阴维脉起于内踝上三寸的三阴交穴，也正符合了阴阳平衡之理[1]。

3 悬钟穴并非髓会

髓会绝骨首见于《难经·四十五难》，而这里的绝骨是否为腧穴，如果是，是哪个腧穴，阳辅还是悬钟，历代争议不断。李志道教授认为，绝骨并非悬钟，而是阳辅，即髓会阳辅。考《针灸甲乙经》腧穴定位原文：“悬钟，在足外踝上三寸动脉中，足三阳络，按之阳明脉绝乃取之。”“阳辅者，火也，在足外踝上四寸，辅骨前，绝骨端，如前三分所，去丘墟七寸，足少阳脉之所行也，为经。”在悬钟的定位中并未提及绝骨二字，反而在阳辅定位中提到“绝骨端”。这里的“绝骨端”指由外踝向上寻按，至骨头被肌肉覆盖而不能触及之处，即腓骨与腓骨长、短肌交接处。李志道教授对 30 名同学进行了实际测试，结果外踝至绝骨端的平均值是 3.85 寸，虽与四寸之说不完全相符，但这与每个个体腓骨长短肌的发达程度不同，在臂臑、承山穴处也常出现这种情况[2]。因此，阳辅定位的关键在于“绝骨端”。而这里的“如前三分”，是为了在绝骨端往前移三分，不要刺到腓骨上。所以从《针灸甲乙经》原文来看，“绝骨端”为阳辅穴的定位关键，《灵枢·本输》也说：“阳辅，外踝之上，辅骨之前，及绝骨之端也。”可见，《灵枢》也是以肌性标志的“绝骨之端”为定位阳辅的依据。综上，阳辅穴确以“绝骨端”定位，所以绝骨当为阳辅，髓会绝骨，那么髓会也当为阳辅，而非悬钟。

参考文献

[1] 李志道.对于阳维起于诸阳会和阴维起于诸阴交的认识.中医杂志，1984，25(8)：54

[2] 李志道.也谈绝骨与悬钟、阳辅穴的关系.上海针灸杂志，1986，5(1)：44

第一作者：田苑(1991—)，女，中医学七年制学生。

通讯作者：李兰媛，副主任医师。lljlmq@126.com

收稿日期：2014-12-19

编辑：华　由　王沁凯

(C)1994-2020 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net